John Bowlby

ATTACCAMENTO E PERDITA

3: La perdita della madre

Programma di Psicologia Psichiatria Psicoterapia

Bollati Boringhieri

Capitolo 3

Il quadro concettuale

> Secondo il nostro tempo e la nostra esperienza, noi rappresentiamo il mondo naturale e umano mediante un grande insieme di immagini. A questo insieme di immagini applichiamo, come un'intelaiatura, un sistema di ipotesi che ci appaiono coerenti. La difficoltà nel progresso scientifico sorge allorché un'esperienza nuova esige una ristrutturazione del nostro schema di immagini.
>
> C.F.A. Pantin (1968)

Sintesi della teoria dell'attaccamento

Lo schema teorico di riferimento da me adottato per studiare il lutto differisce da quelli tradizionali, e può essere utile ricapitolarne alcune caratteristiche fondamentali, soffermandosi su quelle più importanti.

All'inizio del mio lavoro sugli effetti in bambini molto piccoli del trovarsi lontani dalla madre in un luogo sconosciuto, con persone estranee, il mio quadro teorico era quello psicoanalitico. Trovando insoddisfacente la sua sovrastruttura metapsicologica, ho via via elaborato un paradigma che, pur incorporando buona parte del pensiero psicoanalitico classico, se ne differenzia perché vi ho introdotto parecchi princìpi derivati dalle discipline relativamente nuove dell'etologia e della teoria dei sistemi. In forza di ciò, il nuovo paradigma è in grado di fare a meno di molti concetti astratti, come quelli di energia psichica e di pulsione, e di stabilire dei collegamenti con la psicologia cognitiva. I vantaggi che derivano dall'assunzione di tale paradigma sono che i suoi concetti, pur essendo da un lato di natura psicologica e andando d'accordo con i dati clinici che interessano gli psicoanalisti, dall'altro sono compatibili con i concetti della neurofisiologia e della psicologia dello sviluppo, e soddisfano gli abituali requisiti di una disciplina scientifica.[1]

Un vantaggio particolare consiste nel facilitare un modo nuovo e illuminante di concettualizzare l'inclinazione degli esseri umani a stabilire forti legami affettivi con altri esseri umani, e nello spiegare le molteplici forme di disagio emotivo e di disturbi della personalità, come angoscia, rabbia, depressione e distacco emotivo, causati da una separazione e da una perdita non vo-

[1] Per un'esposizione più completa del paradigma vedi capp. 3-10 del primo volume; vedi inoltre Peterfreund (1971), e in particolare le critiche dell'autore ai concetti di energia psichica e di Io (capp. 3, 4) e la lucida esposizione dei concetti fondamentali di ordine, organizzazione, informazione e controllo in biologia (capp. 7-10). Vedi anche il suo recente articolo *On Information and System Models for Psychoanalysis*.

lute. La teoria che ne risulta, che ho definito teoria dell'attaccamento, tratta degli stessi fenomeni finora denominati «bisogno di dipendenza», «relazioni oggettuali» o «simbiosi e individuazione». La teoria dell'attaccamento trae la propria specificità dalle seguenti generalizzazioni:

1) Il comportamento di attaccamento è concepito come qualsiasi forma di comportamento che fa sì che un individuo ricerchi o mantenga la vicinanza di un altro individuo differenziato e preferito. Fintantoché la figura di attaccamento resta accessibile e responsiva, il comportamento di attaccamento può limitarsi al fatto di tenere sotto controllo visivo e uditivo i luoghi in cui essa si trova, con occasionali scambi di occhiate o saluti. Tuttavia, in determinate circostanze, può anche darsi che l'individuo segua la figura preferita o le si aggrappi, o addirittura la chiami o la ricerchi con pianti e grida, che probabilmente hanno lo scopo di suscitarne le cure.

2) Il comportamento di attaccamento, in quanto classe di comportamenti dotata di una dinamica propria, viene concepito come distinto da quello di nutrizione e da quello sessuale, e almeno altrettanto significativo per la vita umana.

3) Il comportamento di attaccamento, in uno sviluppo sano, porta allo sviluppo di legami affettivi o attaccamenti, all'inizio tra bambino e genitore, poi tra adulto e adulto. Le forme di comportamento e i legami a cui esse portano sono presenti e attivi per tutto il corso della vita (quindi assolutamente non limitati all'infanzia, come ipotizzato da altre teorie).

4) Il comportamento di attaccamento, come altre forme di comportamento istintivo, è mediato da sistemi comportamentali che diventano corretti secondo lo scopo in una fase molto precoce dello sviluppo. I sistemi omeostatici di tale natura sono strutturati in modo che, in virtù del feedback o retroazione, viene costantemente individuata ogni eventuale discrepanza tra l'istruzione iniziale e la prestazione in corso, e il comportamento viene modificato di conseguenza. Per pianificare e guidare il comportamento corretto secondo lo scopo si ricorre a modelli costituiti da rappresentazioni sia delle capacità del soggetto sia delle principali caratteristiche dell'ambiente. Lo scopo del comportamento di attaccamento è di mantenere un certo grado di vicinanza – o di comunicazione – con la figura (o le figure) privilegiata di attaccamento.

5) Fintantoché persiste un legame di attaccamento, le varie forme di comportamento di attaccamento che vi contribuiscono sono attive solo quando è necessario. I sistemi che mediano il comportamento di attaccamento vengono attivati soltanto da determinate condizioni, per esempio l'estraneità, la stanchezza, qualsiasi cosa che spaventi, l'inaccessibilità della figura di attaccamento o l'assenza di risposte da parte sua; tale attivazione cessa soltanto allorché si verificano altre condizioni particolari, per esempio un ambiente familiare o la facile accessibilità e la responsività della figura di attaccamento. Quando però l'attivazione del comportamento di attaccamento è stata molto

intensa, perché essa cessi può essere necessario toccare la figura di attaccamento o aggrapparvisi; talora è necessario che la figura di attaccamento assuma attivamente un comportamento rassicurante.

6) Molte emozioni tra le più intense sorgono durante il formarsi, il persistere, il rompersi e il rinnovarsi dei rapporti di attaccamento. La formazione di un legame viene comunemente detta innamoramento, la conservazione di un legame viene chiamata «voler bene a una persona», la perdita di un compagno equivale a sentire la mancanza di qualcuno. Analogamente, ogni pericolo di perdita suscita angoscia, mentre la perdita reale dà luogo a sofferenza; è assai facile che entrambe queste situazioni facciano nascere rabbia. La persistenza di un legame senza alcun pericolo di perdita viene sperimentata come fonte di sicurezza; il rinnovamento di un legame come gioia. Poiché di solito queste emozioni riflettono lo stato dei legami affettivi di un individuo, ne consegue che la psicologia e la psicopatologia delle emozioni coincidono in gran parte con la psicologia e la psicopatologia dei legami affettivi.

7) Il comportamento di attaccamento è diventato caratteristico di molte specie nel corso della loro evoluzione, perché contribuisce alla sopravvivenza dell'individuo, mantenendolo a contatto con chi lo accudisce, e in tal modo diminuendo il rischio di danni, per esempio da freddo, fame, affogamento, e soprattutto, nell'ambiente di adattamento evolutivo dell'uomo, da predatori.

8) Il comportamento che è complementare a quello di attaccamento, e assolve la funzione di proteggere l'individuo che presenta l'attaccamento, è il comportamento di accudimento. Esso si osserva comunemente in un genitore, o in un altro adulto, nei confronti di un bambino o di un adolescente, ma anche in un adulto nei confronti di un altro adulto, soprattutto in caso di malattia, situazioni di emergenza o vecchiaia.

9) Poiché il comportamento di attaccamento è potenzialmente attivo per tutta la vita, e assolve la funzione biologica vitale che qui si è illustrata, consideriamo un grave errore supporre che quando tale comportamento è attivo in un adulto, sia indizio o di patologia o di regressione a un comportamento immaturo. Quest'ultima tesi, caratteristica di quasi tutte le altre versioni della teoria psicoanalitica, deriva da concettualizzazioni che discendono dalle teorie dell'oralità e della dipendenza, che qui vengono respinte, in quanto in disaccordo con i risultati dell'osservazione.

10) La psicopatologia è considerata originata dal fatto che lo sviluppo psicologico di un individuo ha seguito un decorso deviante, e non già dal fatto che egli soffra di una fissazione, o di una regressione, a una fase precoce di sviluppo.

11) Modelli di attaccamento disturbati possono essere presenti a qualsiasi età, se lo sviluppo ha seguito un corso deviante. Una delle forme di disturbo più comuni è un'eccessiva elicitazione di un comportamento di attaccamento, che dà origine a un attaccamento ansioso; un'altra forma – alla quale in questo volume dedicheremo un'attenzione speciale – è una disattivazione parziale o totale del comportamento di attaccamento.

12) Le determinanti principali del corso che assumerà lo sviluppo del comportamento di attaccamento in un dato individuo e del modello in cui finirà per organizzarsi sono le esperienze vissute dall'individuo con le sue figure di attaccamento durante gli anni dello sviluppo: infanzia, fanciullezza e adolescenza.

13) Dall'organizzazione assunta dal comportamento di attaccamento di un individuo all'interno della sua personalità dipende il modello dei legami affettivi che egli stabilisce durante la sua vita.

Entro uno schema di riferimento di questo tipo, non è difficile indicare in qual modo vadano concepiti gli effetti della perdita e gli stati di stress e di acuta sofferenza da essa suscitati.

Stati di stress e di sofferenza angosciosa

Una caratteristica di ogni sistema omeostatico è la sua idoneità a operare in modo efficace soltanto allorché le condizioni ambientali che hanno importanza per il suo funzionamento rimangono entro determinati limiti. Se così non accade, il sistema è sovraccarico e può anche venir meno al suo compito. Prendiamo dalla fisiologia l'esempio del sistema deputato a mantenere nella norma la temperatura corporea: esso opera efficacemente fintantoché la temperatura ambiente è compresa entro certi massimi e certi minimi; allorché li supera per un tempo abbastanza lungo, il sistema non è più in grado di assolvere la sua funzione. Ne consegue che la temperatura corporea sale o scende, e l'organismo soffre di ipertermia o di ipotermia. Le condizioni ambientali che producono siffatti stati fisiologici vengono denominate *stressors* (scatenatori di stress), e gli stati corrispondenti stati di stress. L'esperienza che l'individuo subisce è di acuta sofferenza.

Poiché lo scopo di un comportamento di attaccamento è mantenere un legame affettivo, qualsiasi situazione che sembra mettere in pericolo tale legame suscita un'azione destinata a proteggerlo; maggiore è il pericolo della perdita, più intenso e multiforme è il tipo di azione suscitata per impedirla. In siffatte circostanze vengono attivate tutte le più potenti forme di comportamento di attaccamento (aggrapparsi, piangere e gridare, eventualmente anche una rabbiosa coercizione). È la fase della protesta, in cui lo stress fisiologico è acuto, la sofferenza emotiva intensa. Se tutta questa attività raggiunge il suo scopo, il legame è recuperato, le varie attività cessano, e viene alleviato lo stato di sofferenza e di stress.

Se invece lo sforzo per recuperare il legame non ha buon esito, prima o poi i tentativi vengono meno, senza tuttavia, di solito, cessare del tutto; al contrario, l'osservazione mostra che tali tentativi vengono rinnovati, magari a in-

tervalli sempre più lunghi: vengono nuovamente sperimentati il dolore e forse un impulso alla ricerca della persona perduta. In questo caso la condizione dell'organismo è di stress cronico, e viene vissuta come dolore cronico. A intervalli, tanto lo stress quanto la sofferenza possono riacutizzarsi.

Nei capitoli che seguono approfondiremo questa succinta descrizione; per il momento sarà utile precisare come verranno usati i termini «sano» e «patologico». Seguendo un accenno di Freud (1925), Engel (1961) ha proposto un'analogia molto valida: la perdita di una persona amata, egli afferma con decisione, è altrettanto traumatica, da un punto di vista psicologico, quanto lo è dal punto di vista fisiologico il fatto di venire ferito o ustionato. Invocando i princìpi omeostatici, Engel conclude: «L'esperienza di un semplice dolore rappresenta un'evidente e importante deviazione dallo stato dinamico che viene considerato indicativo di salute e di benessere (...) Esso comprende, oltre alla sofferenza, una menomazione del funzionamento, che può protrarsi per giorni, settimane o addirittura mesi.» Pertanto si possono paragonare i processi di lutto a quelli di guarigione da una ferita grave o da un'ustione. Come sappiamo, i processi di guarigione possono assumere un andamento che con il tempo porta al recupero completo, o quasi completo, della funzione; o invece possono svolgersi in modo diverso, avendo come esito una menomazione più o meno grave della funzione. Analogamente i processi di lutto possono assumere un corso che porta, con il tempo, a un recupero più o meno completo della funzione, cioè al ripristino della capacità di stabilire e mantenere legami affettivi; o viceversa possono prendere un andamento tale da menomare detta funzione in grado maggiore o minore. I termini sano e patologico, così come sono applicabili al decorso assunto dai processi di guarigione fisiologica, possono essere applicati ai diversi andamenti assunti dai processi di lutto. Si deve tuttavia ammettere che in materia di salute e di patologia non si possono tracciare linee nette di demarcazione, e che quello che appare come recupero di una funzione può spesso nascondere un'accresciuta sensibilità a traumi successivi.

L'impostazione di Engel nell'affrontare il problema si dimostra feconda. Se si concepisce una persona impegnata in un processo di lutto come un individuo in stato di squilibrio biologico causato da un cambiamento ambientale subitaneo, è possibile studiare in modo sistematico i processi in corso e le condizioni che li influenzano, analogamente a quanto si fa per le ferite, le ustioni e le infezioni.

Per poter trattare la vasta gamma di reazioni, sane e patologiche, che seguono alla perdita, occorre ampliare il quadro teorico di riferimento testé esposto, in particolar modo per quanto riguarda i concetti di difesa.